

ANTIDIABÉTICOS ORALES

Lucía González Roza, Julio Tito Camino Acha, Pilar Cuesta Fuente.

INTRODUCCIÓN

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
BIGUANIDAS	Metformina	Dianben	Disminución producción hepática de glucosa	Fármaco de elección de inicio en monoterapia No hipoglucemias Coste económico favorable	Fármaco de elección de inicio en monoterapia No hipoglucemias Coste económico favorable	No si FG<30
SULFONILURIAS	Acetohexamida, Clopropanamida, Tolbutamida, Gliclazida, Glimepirida, Glicolidona, Glipizida, Glibenclamida,	Daonil 5mg Diamicron 30 mg Roname 1, 2, 4 mg	Estimulan la liberación de insulina actuando sobre la célula beta pancreática (revelan de reserva pancreática)	Coste económico favorable	Aumento de peso. Aumento del riesgo de hipoglucemias. Se metabolizan por el citocromo P450 2C9 (CYP2C9). Si déficit de la enzima G6PD puede provocar a. hemolítica.	No si FG<30
MEGLITINIDAS	Repaglinida Nateglinida	Novonorm: Prandin 0.5-1-2 mg	Estimulan la secreción de la insulina en el páncreas, cerrando los canales de KATP en la membrana de las células beta pancreáticas.	Útil si predomina hiperglucemia postprandial. Se usa en ERC incluso en diálisis a dosis bajas.	Aumento de peso Aumento del riesgo de hipoglucemias No se debe asociar con gemfibrozilo (aumenta hipoglucemias). Metabolismo hepático.	Repaglinida puede utilizarse en cualquier estadio de ERC
GLITAZONAS (GLITAZOLINAS)	Pioglitazona	Actos 15, 30 y 45mg Glustin 15-30 mg Competact15/850mg Glubrava 15/850mg (pioglitazona 15mg + metformina 850mg)	Incrementa la captación de glucosa por los tejidos y mejora la sensibilidad a la insulina	No hipoglucemias Mejora el control glucémico en ayunas y postprandial Tratamiento de segunda o tercera línea insulina	Retención hídrica Aumenta el riesgo de IC Aumento de peso Posible asociación con cáncer de vejiga Aumento del riesgo de fracturas óseas	No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal No pueden utilizarse en diálisis
INHIBIDORES ALFA GLUCOSIDASA	Acarbosa Miglitol	Glucobay	Actúan a través de la inhibición reversible de la alfa glucosidasa, retrasan la degradación enzimática de disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos en el intestino delgado.	Retrasan y reducen el incremento de la glucosa postprandial en sangre	Contraindicados en pacientes con alteraciones intestinales crónicas. Diarrea y flatulencia Aumento de enzimas de función hepática	No si FG<25

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
INHIBIDORES DPP-4 ((DPP-4)) o Gliptinas	Sitagliptina	Januvia 25, 50,100 Riataben 25,50, 100 Tessavel 25, 50,100 Xelevia 25, 50, 100 Combinaciones con metformina: Efficib 50/1000; Janumet50/1000; Riafor 50/1000; Velmetia 50/1000.	Aumenta secreción de insulina (glucosa-dependiente) Disminuye secreción de glucagón (glucosa-dependiente)	No hipoglucemia Bien tolerados Acción neutra sobre el peso	Urticaria/Angioedema Relación con pancreatitis y enfermedad inflamatoria intestinal Aumento ingresos hospitalarios por ICC	Ajuste de dosis si ERC (no necesita ajuste: LINAGLIPTINA) Reducen microalbuminuria
	Vildagliptina	Xilore 50; Galvus 50 Combinaciones con metformina: Eucress 850/50, 1000/50; Zontad 850/50, 1000/50 Komboglyze 850/50, 1000/50.				
	Saxagliptina	Onglyza 2,5; 5; Combinaciones con metformina: Komboglyze 2,5/500; Komboglyze2,5/1000.				
	Linagliptina	Trajenta 5; Combinaciones con metformina: Jentadueto 2,5/850; Jentadueto 2,5/1000;				
	Alogliptina	Combinación con empagliflozina: Glyxambi 10/5; 25/5 Vipidia 6.25; 12.5; 25 Combinación con pioglitazona: Incrasync 12.5/30; 25/30 Combinación con metformina: Vigdomet 12.5/850; 12.5/1000;				

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
AGONISTA DEL RECEPTOR GLP-1 (arGLP-1)	Dulaglutida	Trulicity 0.75 mg Trulicity 1.5 mg Trulicity 3 mg Trulicity 4.5 mg	La proteína GLP-1 es una incretina intestinal, aumenta la secreción pancreática de insulina en respuesta a la ingesta, entorpece el vaciado gástrico y reduce el apetito. Los incretín miméticos actúan como agonistas sobre los receptores GLP-1, presentan una secuencia semejante	No hipoglucemias Pérdida de peso Injectables vía subcutánea.	Efectos gastrointestinales frecuentes. Precisan visado. Solo financiados si DM e IMC>30.	Exenatida no puede utilizarse si FG<30.
	Exenatida	Byetta 5; 10 mg solución inyectable de liberación inmediata Bydureon 2 mg solución inyectable de liberación prolongada.				
	Liraglutida	Victoza 6mg c/24h vía subcutánea Saxenda 6 mg c/24h vía subcutánea				
	Lixisenatida	Lyxumia 10 ug c/24h vía subcutánea Lyxumia 20 ug c/24h vía subcutáneo				
	Semaglutida	Ozempic 0.25 mg, 0.5mg, 1mg solución inyectable precargada. vía subcutánea semanal.				
	Albiglutida	Eperzan 30, 50mg vía subcutánea semanal.				

ANTIABIÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
INHIBIDORES DE SGLT-2 Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2)	Canagliflozina	Invokana 100, 300. Combinación con metformina: Vokanamet 50/850; Vokanamet 50/1000; Vokanamet 150/850; Vokanamet 150/1000	Disminuyen la reabsorción de glucosa en el riñón. Aumentan la glucosuria	No hipoglucemia. Disminución peso. Disminuyen PA. Disminuyen eventos CV. Efecto diurético .	Infecciones genitourinarias. Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier) Poliuria. Aumento de LDL. Depleción de volumen/hipoTA/ mareo. Canagliflozina: riesgo de amputaciones de extremidades inferiores y fracturas.	No en FG45.
	Dapagliflozina	Forxiga 10. Estrosio 10. Combinación con metformina: Xigduo 5/850. Xigduo 5/1000. Elymest 5/850. Elymest 5/1000.				
	Empagliflozina	Jardiance 10, 25. Synjardy 5/1000, 12.5/1000. Glyxambi 105, 255.				
	Ertugliflozina	Steglatro 5, 15 mg. Combinación con metformina: Segluromet 2.5/850 Segluromet 2.5/1000 Segluromet 7.5/850 Segluromet 7.5/1000				

BIBLIOGRAFÍA

- Arroyoa D, Goicoechea Diezandinoa M. Fármacos Antidiabéticos Orales e Insulinas. Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 2020. Madrid. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-farmacos-antidiabeticos-orales-e-insulinas-330>
- <https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/notas-informativas-medicamentos-de-uso-humano/>.
- <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ficha técnica de cada medicamento.